

Epidémiologie et prophylaxie des infections sexuellement transmissibles

Pr Soumaya Benmaamar

Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et de Santé
Communautaire

FMPDF

Cas clinique 1

- Mme A., 25 ans, se présente à la consultation médicale pour des pertes vaginales inhabituelles et des douleurs pelviennes intermittentes depuis une semaine.
- Elle est célibataire, n'a pas d'antécédent médical significatif, et rapporte avoir eu des partenaires sexuels occasionnels au cours des six derniers mois. Elle n'utilise pas systématiquement de préservatifs.
- À l'examen clinique, le médecin constate :
 - Des pertes vaginales épaisses et blanchâtres.
 - Une sensibilité à la palpation pelvienne.
 - Un col utérin légèrement inflammatoire.
- Des prélèvements cervicaux et vaginaux sont effectués et reviennent positifs pour **Chlamydia trachomatis**.

Cas Clinique 1

- Quels sont les facteurs de risque qui exposent cette patiente à des IST ?
- **Facteurs de risque pour Mme A. :**
 - **Comportements sexuels à risque** : Multiples partenaires sexuels et absence de protection systématique (non-utilisation régulière de préservatifs).
 - **Âge** : Les jeunes adultes (15-24 ans) sont une population particulièrement à risque pour les IST, y compris Chlamydia.
 - **Absence de dépistage régulier** : Mme A. semble ne pas avoir bénéficié de dépistages antérieurs.

Conduite à tenir

1. Prise en charge

- **Traitement efficace:** antibiothérapie
- **Eviter les complications potentielles** : Si non traitée, Chlamydia peut entraîner des séquelles graves comme une maladie inflammatoire pelvienne (MIP) ou l'infertilité.

Conduite à tenir

2. Importance du dépistage et du traitement des partenaires :

- **Prévention de la réinfection** : Si les partenaires ne sont pas traités, Mme A. risque de se réinfecter après le traitement.
- **Rupture de la chaîne de transmission**: Chlamydia est souvent asymptomatique chez les hommes, mais ils peuvent continuer à transmettre l'infection.
- **Santé publique** : Un traitement précoce des partenaires limite la propagation de l'infection dans la communauté.

Conduite à tenir

3. Conseils de prévention pour Mme A

- **Utilisation systématique du préservatif** : Réduction du risque de transmission des IST lors de tout rapport sexuel.
- **Dépistages réguliers** : Les femmes sexuellement actives, surtout avec plusieurs partenaires, doivent se faire dépister annuellement pour Chlamydia et d'autres IST.
- **Éducation sexuelle** : Sensibiliser sur l'importance de la communication avec les partenaires et de la prévention.

Cas clinique 1: conduite à tenir

4. Rôle des stratégies de santé publique :

- **Dépistage ciblé** : Intégrer des campagnes pour encourager le dépistage systématique des jeunes adultes et des groupes à risque.
- **Suivi des contacts** : Les systèmes de santé publique doivent faciliter l'identification et le traitement des partenaires des cas diagnostiqués.
- **Sensibilisation et vaccination** : Par exemple, la vaccination contre le HPV, qui peut coexister avec Chlamydia, contribue à réduire les complications associées.

Cas clinique 2

- M. C., 32 ans, se présente à la consultation avec une fatigue chronique, des sueurs nocturnes, et une perte de poids non intentionnelle (5 kg en 3 mois). Il signale également des épisodes récurrents de candidose orale et des ganglions cervicaux palpables.
- Il n'a pas d'antécédents médicaux significatifs et ne suit pas de traitement habituel. Lors de l'interrogatoire, il mentionne avoir eu des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires au cours des deux dernières années.

Cas clinique 2

• **signes cliniques:** fatigue chronique, sueurs nocturnes, perte de poids, candidose orale, et adénopathies cervicales orientent vers un déficit immunitaire, ce qui est compatible avec une infection VIH avancée.

• **Diagnostic à évoquer:** infection par VIH

• **Examens complémentaires :**

- Test rapide de dépistage du VIH : **positif**.
- Sérologie VIH confirmée par Western blot.
- Charge virale VIH : 150 000 copies/mL.
- CD4 : 180/mm³.
- Tests pour co-infections (hépatites B/C, syphilis, tuberculose) : Hépatite B active détectée.
- Radiographie thoracique : Normale.

Cas clinique 2: conduite à tenir

1. Prise en charge :

- l'approche thérapeutique initiale pour M. C., incluant le traitement antirétroviral (TAR) et la prise en charge de l'hépatite B
- **Prophylaxie des infections opportunistes** : Avec un $CD4 < 200/mm^3$

2. Prévention :

- Que conseiller à M. C. pour éviter de transmettre le VIH à ses partenaires ?
- **Conseils pour le patient** : Initiation rapide du TAR permet de rendre la charge virale indétectable, éliminant pratiquement le risque de transmission (concept de "U=U", *Undetectable = Untransmittable*).
- Usage systématique du préservatif.
- Informer et dépister les partenaires récents pour les inclure dans une éventuelle prise en charge.

Cas clinique 2: conduite à tenir

3. Santé publique :

- Quel rôle joue le dépistage précoce dans la prévention du VIH à l'échelle individuelle et communautaire ?
- **Importance du dépistage précoce** : Le dépistage permet un diagnostic à un stade précoce, limitant la progression vers le sida et réduisant le risque de transmission à d'autres personnes.
- L'intégration des stratégies de prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la sensibilisation à l'utilisation du préservatif sont des piliers des programmes de lutte contre le VIH.

Plan du cours

- **Généralités**
 - Définition
 - Modes de transmission
 - Facteurs de risque
 - Populations à risque
- **Ampleur du problème**
 - Au niveau international
 - Au niveau national
- **Prophylaxie: Moyen de lutte**
- **Conclusion**

Définition

- **Le terme « infection sexuellement transmissible (IST) »:** une infection qui est transmise par le sang, le sperme, les liquides vaginaux ou d'autres fluides corporels lors de rapports sexuels oraux, anaux ou génitaux avec un partenaire infecté.
- **La maladie sexuellement transmissible (MST):** une maladie qui se développe à partir d'une IST.
- Autres voies de transmission: le partage de seringues contaminées, la transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement ou l'allaitement.

Agents pathogènes

Types d'infection sexuellement transmissible

Type	Maladie
Bactérien	Chancre mou Urétrite et cervicite à Chlamydia Gonorrhée Granulome inguinal Lymphogranulome vénérien Syphilis
Viral	Herpès génital à herpès simplex Verrues génitales (dues au papillomavirus humain) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou SIDA Molluscum contagiosum (due à un poxvirus)
Parasitaire (protozoaire)	Trichomonase
Arthropode	Infestation pubienne par les poux Gale (due à un acarien qui creuse des galeries)

Modes de transmission

- **Contact sexuel :**

- Mode de transmission le plus courant
- Les IST se transmettent généralement lors de relations sexuelles vaginales, anales ou orales avec une personne infectée.
- Le sperme, les sécrétions vaginales et les muqueuses (comme celles du pénis, du vagin, de la bouche ou du rectum) sont des vecteurs de transmission.

- **Contact peau à peau :**

- Transmission par un simple contact entre la peau infectée et la peau saine, même en l'absence de rapport sexuel complet ou de pénétration: herpès génital ou l'HPV

Modes de transmission

- **Transmission sanguine :**

- Le partage de seringues ou d'aiguilles contaminées par une personne infectée peut transmettre certaines IST: le VIH, le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC).

- **Transmission mère-enfant :**

- Pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement, une mère infectée peut transmettre certaines IST (comme le VIH, la syphilis ou l'herpès) à son enfant.

- **Transfusion sanguine ou greffe d'organe :**

- rare
- la transmission peut survenir si le sang ou les organes transplantés sont contaminés.

Facteurs de risque

Certains comportements ou situations augmentent le risque de contracter une IST:

- **Absence de vaccination:** absence de vaccination contre le HPV ou l'hépatite B augmente le risque d'infection par ces virus.
- **Partage de matériel d'injection:** Le partage d'aiguilles ou de matériel pour l'injection de drogues est un vecteur majeur pour les IST comme le VIH ou les hépatites B et C.

Facteurs de risque

- **Manque d'accès au dépistage et aux soins :**
 - Un accès limité aux services de santé, au dépistage ou aux traitements appropriés: la transmission continue des IST.
 - les populations défavorisées ou marginalisées.
- **Immunodépression :**
 - Les personnes ayant un système immunitaire affaibli (par exemple, à cause du VIH ou de certains traitements médicaux): plus susceptibles de contracter des IST et d'en développer des formes plus graves.

Facteurs de risque

- **Rapports sexuels non protégés :**

- L'absence d'utilisation de préservatif, que ce soit pour les relations vaginales, anales ou orales, augmente considérablement le risque de transmission des IST.

- **Multiple partenaires sexuels :**

- Avoir plusieurs partenaires sexuels accroît l'exposition potentielle aux IST.

Facteurs de risque

- **Âge jeune:**

- Les jeunes, en particulier les adolescents et les jeunes adultes: plus à risque.
- plus grande fréquence de comportements sexuels à risque, d'une méconnaissance des IST, et d'un dépistage souvent insuffisant.

- **Antécédents d'IST :**

- Avoir contracté une IST par le passé augmente le risque d'en contracter d'autres: certaines IST peuvent affaiblir le système immunitaire et rendre la personne plus vulnérable à d'autres infections.

Population à risque

- Professionnelles du sexe
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
- Personnes qui s'injectent des drogues
- Populations migrantes
- Population carcérale

Ampleur du problème VIH au niveau mondial

Rapport de l'ONUSIDA:

- **39,9 millions de personnes** [36,1-44,6 millions] vivaient avec le VIH dans le monde en 2023.
- **1,3 million** [1-1,7 million] de personnes ont été infectées par le VIH en 2023.
- **630 000** [500 000-820 000] personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2023.
- **30,7 millions de personnes** [27-31,9 millions] avaient accès à une thérapie antirétrovirale en 2023.

Ampleur du problème

Données mondiales sur le VIH

	2000	2005	2010	2020	2022	2023
Personnes vivant avec le VIH	27,2 millions [24,6 millions-30,4 millions]	29,4 millions [26,6 millions-32,9 millions]	32 millions [29 millions-35,8 millions]	38,7 millions [35 millions-43,2 millions]	39,5 millions [35,8 millions-44,2 millions]	39,9 millions [36,1 millions-44,6 millions]
Nouvelles infections au VIH	2,8 millions [2,3 millions-3,6 millions]	2,5 millions [2 millions-3,2 millions]	2,1 millions [1,7 million-2,7 millions]	1,5 million [1,2 million-1,9 million]	1,4 million [1,1 million-1,7 million]	1,3 million [1 million-1,7 million]
Décès liés au sida	1,8 million [1,4 million-2,3 millions]	2 millions [1,6 million-2,6 millions]	1,3 million [entre 1 et 1,7 million]	730 000 [570 000-940 000]	670 000 [530 000-870 000]	630 000 [500 000-820 000]
Nouvelles infection au VIH (adultes de 15 ans et +)	2,3 millions [1,9 million-3 millions]	2 millions [1,6 million-2,6 millions]	1,8 million [1,5 million-2,4 millions]	1,3 million [1,1 million-1,7 million]	1,2 million [980 000-1,6 million]	1,2 million [950 000-1,5 million]
Nouvelles infections au VIH (enfants de 0 à 14 ans)	530 000 [380 000-760 000]	470 000 [340 000-680 000]	300 000 [220 000-440 000]	150 000 [110 000-210 000]	130 000 [94 000-190 000]	120 000 [83 000-170 000]
Personnes ayant accès à une thérapie antirétrovirale	510 000 [450 000-530 000]	1,9 million [1,7 million-2 millions]	7,7 millions [6,7 millions-8 millions]	26,2 millions [23,1 millions-27,3 millions]	29,3 millions [25,7 millions-30,4 millions]	30,7 millions [27 millions-31,9 millions]
Ressources disponibles	5,1 milliards de dollars	9,3 milliards de dollars	16,7 milliards de dollars	21,5 milliards de dollars	20,8 milliards de dollars	19,8 milliards de dollars

Source : estimations épidémiologiques de l'ONUSIDA, 2024 Estimations financières de l'ONUSIDA, juillet 2024 (<http://hivfinancial.unaids.org/hivfinancialdashboards.html>).

Ampleur des autres IST

- **Données de l'OMS:**

- Chaque jour dans le monde, **plus d'un million** de personnes âgées de 15 à 49 ans contractent une infection sexuellement transmissible (IST), asymptomatique dans la majorité des cas et dont on peut guérir.
- En 2020, **374 millions de personnes** âgées de 15 à 49 ans auraient contracté selon les estimations l'une des quatre IST suivantes, dont on peut guérir : chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonase.

Ampleur des autres IST

- **8 millions** d'adultes âgés de 15 à 49 ans ont contracté la syphilis en 2022.
- **Plus de 500 millions** de personnes âgées de 15 à 49 ans ont une infection génitale par le virus herpès simplex (HSV ou herpès).
- L'infection par le virus du papillome humain (HPV) est associée à plus de **311 000 décès** dus au cancer du col de l'utérus chaque année .

Ampleur des autres IST

- **1,1 million** de femmes enceintes étaient infectées par la syphilis en 2022, ce qui a entraîné lors de l'accouchement plus de 390 000 issues défavorables.
- Les IST ont une incidence directe sur la santé sexuelle et reproductive à travers:
 - la stigmatisation
 - l'infertilité
 - les cancers
 - les complications de la grossesse
 - le risque de contracter le VIH

Données nationales sur le VIH/sida

- l'épidémie de VIH/sida est stabilisée depuis plusieurs années avec un niveau de prévalence bas.
- l'impact global de la riposte nationale au VIH depuis plus de 30 ans.
- la prévalence du VIH reste stable en population générale (15 ans et plus), estimée à **0,07%** [0,07-0,08].
- Le niveau de prévalence qui varie selon le genre **0,08% parmi les hommes et 0,07% parmi les femmes.**

Données nationales sur le VIH/sida

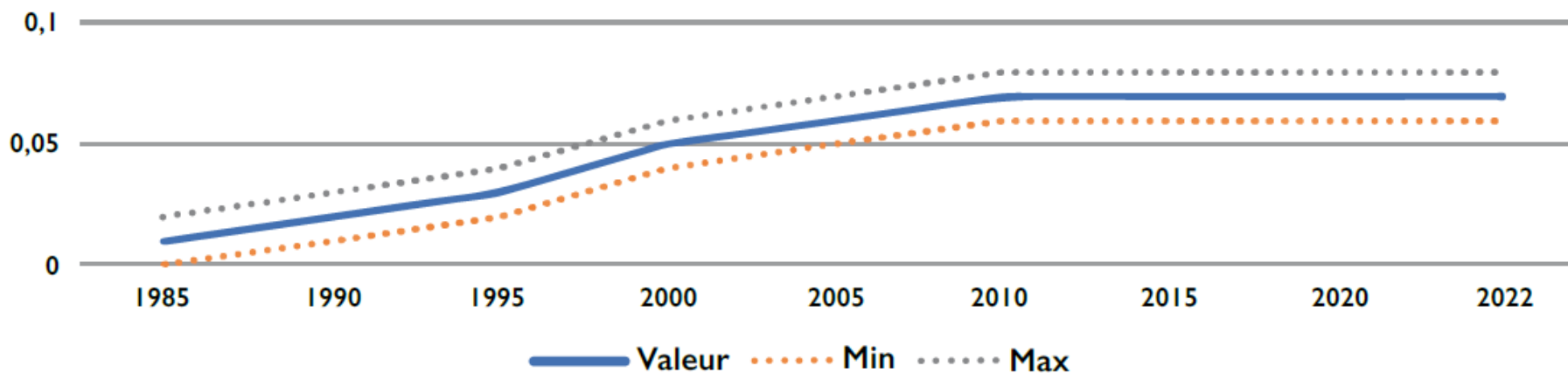


Figure 4 : Évolution de la prévalence du VIH (Source : Rapport National sida 2023)

Données nationales sur le VIH/sida

Tableau 1: *Prévalence du VIH chez les Populations clés (IBBS)*

Ville	PS	HSH	PID	Migrants
Estimation de taille (2022)	73.000	46.000	1.300	40.000
National	2,35% (2022 IBBS)	4,1% (2020 IBBS)	7,1% (2017 IBBS)	4,6% (2022 IBBS)

Données nationales sur le VIH/sida

- L'estimation du nombre des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est de **21.600** en fin 2022 :
 - 44% de femmes
 - 42% d'adultes
- 816 enfants âgés de moins de 15 ans (4 %).



Figure 5 : Répartition par sexe des PVVIH (gauche) et des nouveaux cas (droite) avec proportion d'enfants

Données nationales sur le VIH/sida

- L'incidence du VIH **pour 1 000 personnes est stable à environ 0,02%.**
- Les nouvelles infections:
 - réduction significative et continue depuis 2010 (-50% entre 2010 et 2022), avec:
 - 760 nouvelles infections estimées en 2022.
 - Nouvelles infections: t 24%de femmes, 69% d'hommes et 7% d'enfants.

Données nationales sur le VIH/sida

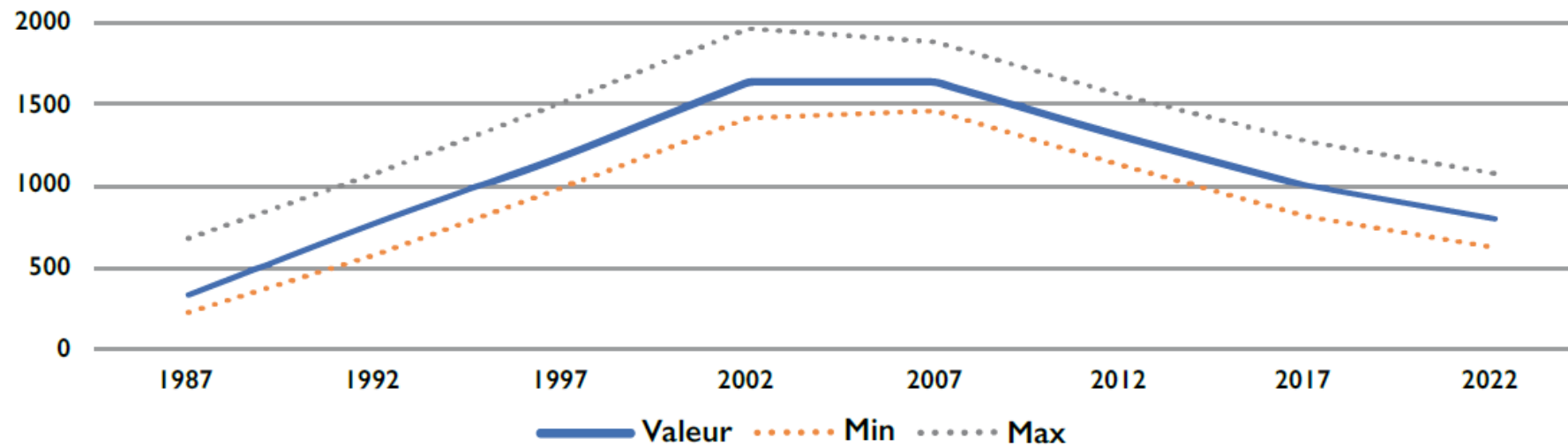


Figure 6 : Évolution des nouvelles infections VIH (Rapport National sida 2023)

Données nationales sur le VIH/sida

Au total, 72% de ces infections se produisent dans le réseau des populations clés: (PID, HSH, PS et leurs clients et partenaires), dont 41% chez les clients des PS et 15% chez les HSH.

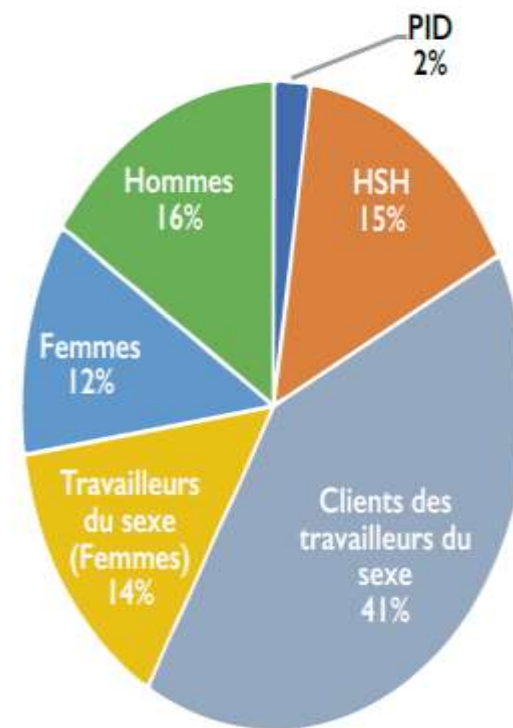


Figure 7 : Origine des nouvelles infections VIH

Données nationales sur le VIH/sida

- Les décès dus au sida ont diminué de 840 en 2010 à 360 en 2022, soit 57% de réduction.
- En 2022, on estimait qu'environ 66% des décès sont survenus parmi les hommes.

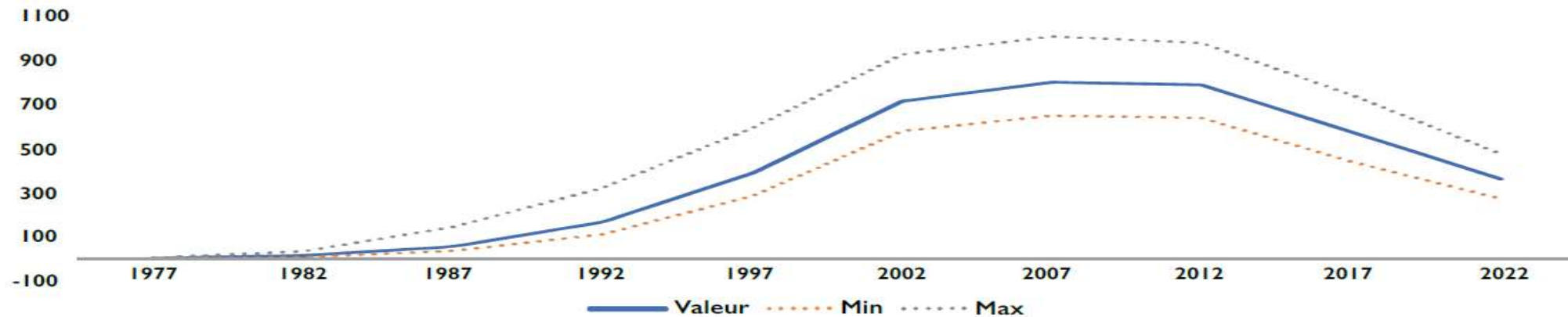


Figure 9 : Évolution des décès dus au sida et distribution par sexe
(Rapport National sida 2023)

Données nationales sur le VIH/sida

- la prévalence chez les femmes enceintes est de **0,1%** (0,06% en 2019 ; 0,11% en 2022)
- Taux supérieurs à 0,2% dans certaines villes: sud du Maroc.
- le nombre estimé des femmes enceintes vivant avec le VIH était **de 390 en 2022.**

Données nationales sur le VIH/sida

- Le taux de transmission verticale du VIH incluant la période d'allaitement reste élevé, estimé à **10,5% en 2022**.
- Ce niveau de transmission verticale du VIH aurait occasionné 94 cas d'infection à VIH pédiatriques en 2022.
- Ces résultats montrent que les efforts fournis pour réduire la transmission verticale du VIH n'ont pas donné les résultats escomptés durant ces dernières années.

Fardeau des autres maladies transmissibles

- Nombre annuel moyen de cas d'IST notifiés de **400 000 durant les 5 dernières années (517 000 en 2017 et 285 600 en 2021)**.
- Diminution est réellement due à une réduction réelle des IST ou à des problèmes de notification des cas (contexte de la COVID-19 en 2020 et 2021 ?)
- La part la plus importante de ces cas revient au:
 - Pertes vaginales (75% des notifications, soit 300 000 en moyenne)
 - les écoulements urétraux (60 000 en moyenne).
 - Le nombre annuel d'ulcérations génitales et de maladies inflammatoires pelviennes varie autour de 3 000 par an chacun.

Fardeau des autres maladies transmissibles

- En 2016: incidence annuelle globale des IST au Maroc à **800 000**.
- Prévalence des IST:
 - **Neisseria gonorrhea** : 0,37% chez les femmes et 0,32% chez les hommes.
 - **Chlamydia trachomatis**: 3,8% chez les femmes et 3,0% chez les hommes.
 - **la syphilis**: chez les femmes: 0,57%

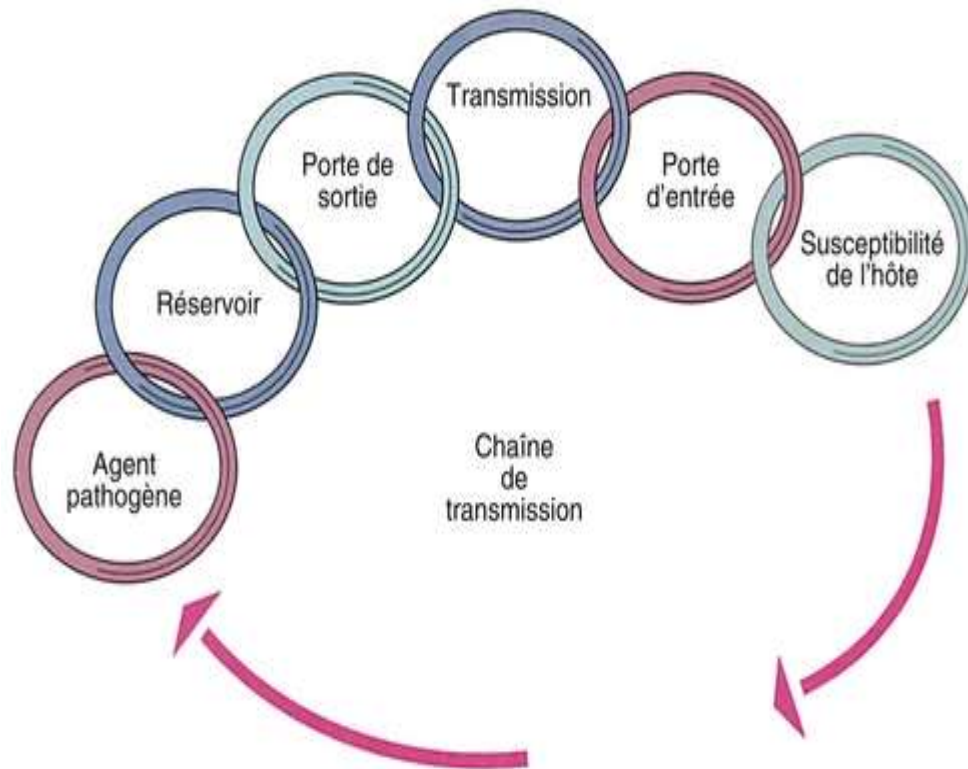
Fardeau des autres maladies transmissibles

Tableau 2: *Prévalence des germes dans les syndromes d'IST et chez les femmes consultant aux ESSP*

Données d'étude	Prévalences					
Population	NG	CT	TV	Syphilis	VIH	Année
Femmes PV et/ou DbV	1%	6%	5%	2,4%	0,2%	2007
PS PV et/ou DbV	7%	19%	15%	13,8 %	1,5%	2007
Homme EU	62,8%	10,3%	4%	2,3 %	0%*	2009
Femmes SMI/PF	0,5%	3,3%	5,4%	0,3%	0%*	2013

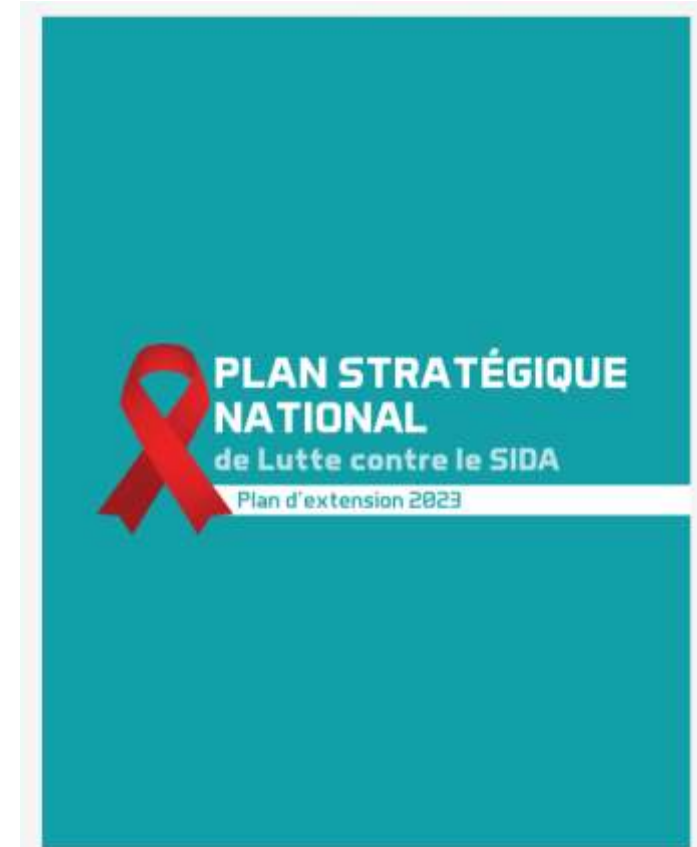
CT : *Chlamydia Trachomatis* ; DbV : douleur du bas ventre ; NG : *Neisseria Gonorrhea* ;
 EU : *Ecoulement Urétral* ; PS : *Professionnelles du sexe* ; PV : *Pertes vaginales* ;
 SMI/PF : *Santé maternelle et Infantile/ Planification Familiale* ; TV : *Trichomonas Vaginalis*

Moyens de lutte



Moyens de lutte

**Objectif: lutter contre le
SIDA d'ici 2030**



Références: ODD



Les ODD 2030 : (cible 3.3 des ODD)

Mettre fin au sida à l'horizon 2030

Références



Prévention et lutte contre le VIH et des IST

❑ Ciblage des populations clés :

- Les actions de prévention sont particulièrement orientées vers **les populations les plus exposées :**
 - les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
 - les travailleuses du sexe
 - les personnes usagères de drogues injectables
 - les migrants

Prévention primaire

- **Éducation à la sexualité :**
 - programmes d'éducation sexuelle pour les jeunes
 - un accent sur la prévention du VIH, des IST et des grossesses non désirées.
- **Promotion de la prophylaxie pré-exposition (PrEP):** Le Maroc a introduit la PrEP pour les personnes à risque élevé d'infection par le VIH.
- **Promotion de l'utilisation du préservatif :**
 - Des campagnes de sensibilisation
 - distribution gratuite de préservatifs sont menées.
 - les centres de santé, les ONG et les lieux fréquentés par les populations clés.

Prévention primaire

- **Réduction des risques pour les usagers de drogues injectables**

- **Programmes d'échange de seringues** : Des programmes sont mis en place pour réduire la transmission du VIH chez les usagers de drogues injectables, via la distribution de seringues stériles et l'accès à des services de réduction des risques.

- **Substitution aux opioïdes** : Un programme de traitement de substitution aux opioïdes, avec la méthadone, est disponible pour les toxicomanes, en complément d'un accompagnement social et médical.

Prévention primaire: Vaccination

- On dispose de vaccins sûrs et particulièrement efficaces contre deux IST virales : **l'hépatite B et le HPV.**
- À la fin de 2023: 140 pays, principalement des pays à revenu intermédiaire ou à revenu élevé, avaient introduit le vaccin anti-HPV dans leur programme de vaccination systématique.
- Les recherches visant à mettre au point des vaccins contre le virus de l'herpès génital sont bien avancées.

Prévention primaire: Vaccination

Programme National d'Immunisation

Calendrier national de vaccination 2023

Vaccin contre \ Age	Naissance	Semaines						Mois				Années	
		Durant les 4 premières semaines	8	10	12	16	18	6	9	12	18	5	11
l'Hépatite B (HB)	HBn administré à la naissance												
	Si dose non administrée à la naissance	HB 1											
Tuberculose (BCG)		BCG											
Poliomyélite (oral)		VPO 0	VPO 1		VPO 2	VPO 3					VPO 4	VPO 5	
DTC-Hib-HB (Vaccin Pentavalent)			Penta 1		Penta 2	Penta 3							
Pneumococcique				PCV 1			PCV 2	PCV 3		PCV 4			
Rotavirus			Rota 1		Rota 2	Rota 3							
Poliomyélite (inactivé)						VPI							
Rougeole et Rubéole (RR)									RR 1		RR 2		
Diphthérie, le Tétanos et la Coqueluche (DTC)											DTC 1	DTC 2	
Papillomavirus (HPV)													HPV 2 doses

Prévention secondaire: Dépistage et diagnostic précoce

- **Dépistage = détection précoce**

- **Communautaire** : Le plan encourage le dépistage dans les communautés à travers des ONG, avec des tests rapides du VIH et des IST, en complément des services offerts dans les centres de santé.

- **En milieu clinique** : Tous les centres de soins primaires et les hôpitaux sont équipés pour offrir des tests de dépistage rapide et confidentiel.

- **Dépistage massif** : Des campagnes de dépistage régulier

- **Initiation au traitement immédiat** : Pour toute personne dépistée positive, un accès rapide au traitement antirétroviral est assuré, conformément à la stratégie "**Test and Treat**".

Prise en charge des personnes vivant avec le VIH

- **Traitement antirétroviral (ARV)** : Le Maroc garantit un accès universel et gratuit aux traitements ARV pour toutes les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
- **Suivi médical et psychosocial** : Le suivi des PVVIH inclut une surveillance régulière de la charge virale et une prise en charge globale (physique et psychologique) pour améliorer la qualité de vie des patients.
- **Réduction de la stigmatisation et de la discrimination** : Le plan comprend des actions de sensibilisation visant à lutter contre les préjugés et les discriminations dans les établissements de santé, les lieux de travail et la société.

Renforcement des systèmes de santé

- **Renforcement des capacités des professionnels de santé “formations continues”:**

- Dépistage
- Prise en charge
- Traitement des personnes vivant avec le VIH et les IST.

- **Approvisionnement en médicaments et matériel médical :** Une gestion optimale des stocks de médicaments ARV, de tests de dépistage et de matériel de prévention est assurée pour éviter les ruptures d'approvisionnement.

- **Système d'information sanitaire :** Amélioration de la surveillance épidémiologique pour collecter des données précises sur la prévalence du VIH et des IST et suivre l'impact des interventions.

Surveillance épidémiologique et recherche

- **Surveillance biologique et comportementale** : Des études régulières sont menées pour évaluer l'évolution de l'épidémie du VIH et des comportements à risque chez les populations clés.
- **Recherche opérationnelle** : Le Maroc soutient la recherche sur de nouvelles approches de prévention et de traitement, en collaboration avec des partenaires internationaux.
- **Évaluation des programmes** : Des évaluations régulières du plan national sont menées pour ajuster les interventions et maximiser leur impact.

Partenariats et financement

- **Collaboration avec les ONG** : Le plan national travaille en étroite collaboration avec des associations et des ONG locales qui jouent un rôle clé dans la prévention, le dépistage et le soutien aux PVVIH.
- **Financement international** :
 - le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
 - l'ONUSIDA pour atteindre les objectifs globaux de lutte contre le VIH.

Conclusion

- IST: problème de santé publique
- **le plan marocain de lutte contre le VIH et les IST:**
 - Approche multisectorielle
 - Combinaison de la prévention, le dépistage, le traitement, la réduction de la stigmatisation et la collaboration avec les partenaires locaux et internationaux,
 - Objectif :réduire l'incidence des nouvelles infections et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées.